

Ce que la personne voit et fait

Onze planches, dans l'ordre. Ce n'est pas un film : à chaque planche, quelque chose est attendu de la personne — et le temps continue de courir si elle ne fait rien. Sous chaque image, ce qui est à l'écran, ce qu'elle peut faire, ce que l'appareil dit, et ce que le journal enregistre.

01

0:00



Vous arrivez

À L'ÉCRAN Une personne au sol, immobile.
Un passant, à distance, qui ne fait rien. Rien d'autre — pas de menu, pas de consigne.

ON PEUT S'approcher. Parler fort. Toucher l'épaule.

L'APPAREIL —

MESURÉ Le délai avant le premier geste.

02

0:08



Elle ne réagit pas

À L'ÉCRAN Le thorax en évidence. Un compte à rebours discret de dix secondes s'il regarde la respiration.

ON PEUT Regarder si le thorax se soulève, dix secondes au plus. Il est possible de chercher un pouls — et c'est une faute.

L'APPAREIL —

FAUTE POSSIBLE Chercher un pouls · secouer la personne · la déplacer.

MESURÉ Durée de l'examen. Recherche de pouls, si elle a lieu.

03

0:22



Vous désignez quelqu'un

À L'ÉCRAN

Le passant devient désignable.
Deux ordres possibles, à donner
séparément.

ON PEUT

« Vous, appelez le 911. » Puis : «
Vous, allez chercher le
défibrillateur. » Crier au vide ne
produit rien.

L'APPAREIL

—

FAUTE
POSSIBLE

Partir soi-même chercher
l'appareil et laisser la victime
seule.

MESURÉ

Délai jusqu'à l'appel. Délai jusqu'à
l'envoi. Ordre donné à personne
en particulier.



Vous compressez

- À L'ÉCRAN Le buste, les mains, l'horloge. Aucun compteur 30/2, aucune jauge — au troisième passage, plus rien du tout.
- ON PEUT Comprimer, au rythme. Rien ne force à continuer : le temps passe si l'on s'arrête.
- L'APPAREIL Rien. L'appareil n'est pas là.
- MESURÉ Cadence. Interruptions. Fraction du temps sans compression.



L'appareil arrive

- À L'ÉCRAN Le passant revient avec le défibrillateur et le pose. Les compressions continuent tant qu'on ne s'arrête pas.
- ON PEUT Continuer à compresser jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à être ouvert.
- L'APPAREIL —
- MESURÉ Temps d'arrêt des compressions pendant la mise en service.

06

2:00



Vous ouvrez l'appareil

À L'ÉCRAN La coque, telle qu'elle existe déjà. Elle s'allume et parle.

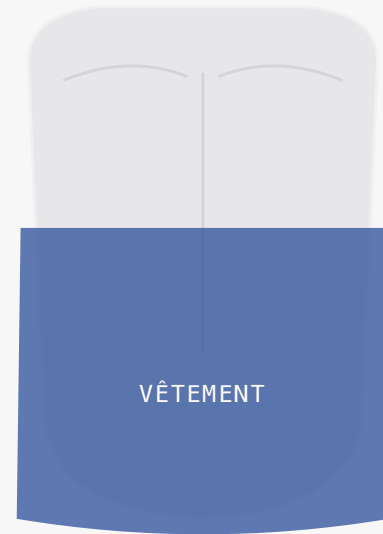
ON PEUT Allumer. Écouter.

L'APPAREIL « *Dénudez la poitrine du patient. Appliquez les électrodes.* »

MESURÉ Délai entre l'arrivée de l'appareil et sa mise en marche.

07

2:06



Le thorax — un obstacle

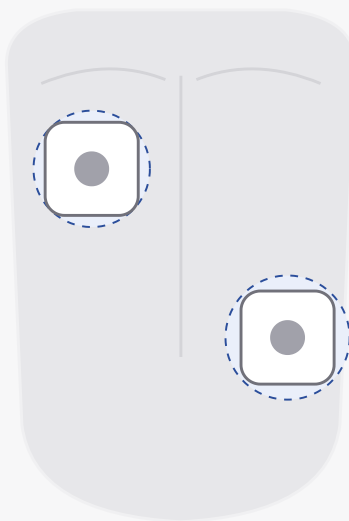
À L'ÉCRAN Gros plan du thorax. Un obstacle sur cinq, tiré au sort : vêtement, thorax mouillé, timbre médicamenteux, pilosité, stimulateur cardiaque. Une trousse — linge, rasoir — quand elle sert.

ON PEUT Retirer ce qui se retire. Essuyer ou raser quand il faut apporter un objet. Le stimulateur, lui, ne s'enlève pas : c'est la pose qui doit s'écarter.

L'APPAREIL « *Appliquez les électrodes.* » (elle se répète, sans jamais dire ce qui bloque)

FAUTE POSSIBLE Poser une électrode sur le vêtement, sur le timbre, sur le boîtier.

MESURÉ Obstacle tiré. Résolu ou contourné. Temps passé.



Vous posez les électrodes

À L'ÉCRAN

Deux pastilles à faire glisser. Les zones de tolérance sont invisibles pour la personne : elles sont dessinées ici pour la conception. Sur les pastilles, le pictogramme imprimé sur les vraies électrodes — c'est un repère qui existe dans le monde, donc il reste.

ON PEUT

Glisser les deux électrodes. Sous la clavicule droite à droite du sternum ; ligne axillaire moyenne à gauche.

L'APPAREIL

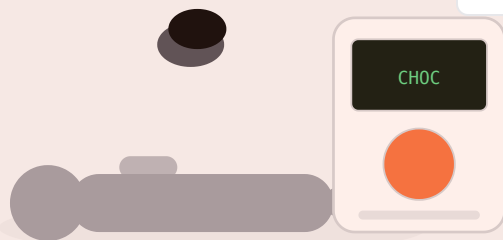
Si c'est mal posé : « Vérifiez les électrodes. » Jamais « trop haut » — un appareil ne corrige pas, il refuse.

MESURÉ

La position exacte des deux dépôts, en coordonnées. Inversion. Nombre d'essais. C'est la mesure qui dira s'il faut enseigner le placement ou seulement le rappeler.

09

2:31



Écartez-vous

À L'ÉCRAN

La page entière bascule en registre d'urgence — comme aujourd'hui. Les mains doivent quitter le thorax.

ON PEUT

Retirer ses mains. Regarder autour. Puis appuyer.

L'APPAREIL

« *Écartez-vous. Ne touchez pas le patient. Appuyez sur le bouton clignotant.* »

FAUTE
POSSIBLE

Appuyer en gardant une main posée.

MESURÉ

Les mains ont-elles quitté le thorax avant l'appui ? Délai jusqu'au choc.

10

2:34



REPRENEZ

Et vous reprenez — tout de suite

À L'ÉCRAN

Rien ne se passe à l'écran. La victime ne se réveille pas. C'est le moment où l'on attend, et c'est la faute la plus coûteuse.

ON PEUT

Recommencer les compressions dans la seconde.

L'APPAREIL

« *Reprenez la réanimation.* »

FAUTE
POSSIBLE

Regarder la victime en espérant qu'elle se réveille.

MESURÉ

Le délai entre le choc et la première compression suivante. C'est le nombre le plus révélateur du dispositif.



FRACTION SANS COMPRESSION

28 %

CE QUE LA SIMULATION N'ÉVALUE PAS...

Le bilan

À L'ÉCRAN	La ligne de temps du passage, la fraction sans compression, les deux délais — et la liste de ce qui n'a pas été évalué.
ON PEUT	Lire. Puis recommencer, avec moins de soutien et un autre obstacle.
L'APPAREIL	—
MESURÉ	Tout ce qui précède, versé au journal de passage.

SUR LES DESSINS

Les planches 01, 02, 03 et 05 sont des illustrations produites par génération, et la 04 est la planche de compression qui vit déjà au dépôt — d'où son style, identique par construction. Elles sont toutes, dans le style des planches de RCP déjà au dépôt : sur une scène, c'est la crédibilité qui compte. Les autres cadres restent des croquis, et le torse des planches 07 et 08 est un **vecteur construit sur des repères anatomiques nommés** — fourchette sternale, clavicules, rebord costal, ligne axillaire. La règle qui sépare les deux : **générer ce qui doit être crédible, construire ce qui doit être exact**. La tolérance de pose vaut trente unités du dessin, ce qui n'a de sens que si ces repères sont justes les uns par rapport aux autres ; aucun modèle d'image ne le garantit.

Un défaut assumé sur la planche 03 : le sauveteur paraît enjamber les jambes de la personne, alors qu'on s'agenouille à côté. Deux passes de correction n'ont rien changé — c'est le même mur que la planche d'insufflation du dépôt, où la main reste sur la joue. Le croquis dit le geste ; la consigne écrite dit ce que l'image manque.

Ce qui n'est jamais demandé à la personne. Déplacer la victime : c'est une faute dans presque tous les cas. Prendre un pouls : même les professionnels s'y trompent, et le temps passé à chercher est du temps sans compression. Décider si le rythme est défibrillable : **c'est l'appareil qui décide du**

choc. La division du travail est exactement celle-ci — l'humain décide de commencer, la machine décide de défibriller — et c'est ce qu'un témoin ignore.

Storyboard de la proposition « Les trois premières minutes ». Les planches 6 à 8 constituent le lot 1, dont la logique de jugement est écrite et éprouvée ; l'interface se construit sur ce cadrage. Les planches 1 à 5 et 9 à 11 relèvent des lots 2 et 3 et ne sont pas engagées.